SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA IPB · PROGRAM STUDI ILMU GIZI · SENIN, 2 NOVEMBER 2026

IPB University
Bogor Indonesia

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin

Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[2], Lilik Kustiyah[2], Irman Hermadi[3]

[1]Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [2]Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [3]Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor
0813-8172-4884
am_marhamah@apps.ipb.ac.id

SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting
Edukasi gizi prakonsepsi online 8 minggu berbasis *Health Belief Model* (HBM)

1 Abstrak

Latar belakang Bukti penggunaan media sosial (medsos) calon pengantin (catin) dan kinerja edukasi gizi prakonsepsi online di Indonesia masih terbatas.

Tujuan Mengevaluasi implementasi platform web SHINING kelompok kontrol serta menganalisis penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT.

Metode *Cross-sectional* dan evaluasi proses; data awal catin Kota Binjai (Juli–Oktober 2026): 198 pendaftar, 74 dengan data lengkap.

Hasil Hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; penurunan terbesar sebelum tes pengetahuan 48 butir. Kiriman ganda 13,8%; blok makanan pokok hilang pada 26,9% FFQ. WhatsApp dominan (59,5%). Pengetahuan baik 59,5% dan berkorelasi dengan sikap (r=0,414), namun 51,4% berat badan lebih/obesitas. IMT lebih rendah berhubungan dengan durasi medsos lebih lama (r=−0,331) dan sumber akun tenaga kesehatan; memeriksa kebenaran informasi berhubungan dengan sikap lebih positif (r=0,287).

Simpulan Edukasi online perlu mengarahkan catin ke sumber kredibel dan membiasakan verifikasi informasi; platform perlu instrumen ringkas, konfirmasi penyimpanan di server, dan uji coba pada kelompok sasaran.

Kata kunci: calon pengantin, edukasi online, evaluasi proses, gizi prakonsepsi, media sosial

2 Pendahuluan

Latar belakang

±50% orang dewasa Indonesia berat badan lebih/obesitas

44–77% catin di Bogor & Jakarta Barat berpengetahuan gizi kurang

72,78% penduduk mengakses internet; 77,57% untuk medsos

±50% unggahan gizi akun populer tidak akurat

Masalah utama

- Masa prakonsepsi periode kritis memperbaiki gizi & kesehatan catin sebagai calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan.
- Dewasa muda mencari info kesehatan di medsos, padahal misinformasi gizi luas; dalam HBM, medsos = *isyarat bertindak*.
- Edukasi online catin hasilnya beragam; intervensi prakonsepsi berbasis HP efeknya masih terbatas.
- Angka berhenti tinggi (*law of attrition*), sehingga cara platform dikembangkan dan digunakan perlu dilaporkan.
- HP spesifikasi rendah, HP bersama, dan jaringan tidak stabil menjadi hambatan tersering.

Tujuan penelitian

(1) Mengevaluasi proses implementasi platform web media edukasi SHINING, meliputi penyelesaian pengisian dan mutu data; **(2)** menganalisis pola penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT, sebagai dasar pengembangan edukasi gizi prakonsepsi online yang mudah digunakan.

3 Metode

Desain	*Cross-sectional* + evaluasi proses, bagian dari riset pengembangan SHINING (model ADDIE)
Subjek	Catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur kode QR & WhatsApp; **198** memenuhi syarat, **74** dianalisis (30 laki-laki, 44 perempuan)
Instrumen	Pengetahuan 48 butir (baik >80%); sikap 24 butir, 6 konstruk HBM, Likert 4 poin (positif ≥72); FFQ; IPAQ-SF; kuesioner medsos; IMT dari BB/TB isian sendiri (PNPK 2025)
Analisis	Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khi-kuadrat/eksak Fisher; hubungan bermakna diuji ulang dengan kontrol peran; p<0,05; Python & SPSS
Waktu & lokasi	Pembinaan catin Kota Binjai, Sumatera Utara; Juli–Oktober 2026
Etik	KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025; persetujuan elektronik
Indikator proses	Penyelesaian & lama pengisian (*timestamp*), kiriman ganda, karantina, data hilang; kemudahan dinilai 15 mahasiswa (skala 1–5)

Fokus makalah
Proses implementasi (Tujuan 1) & pola medsos (Tujuan 2) pada data awal kelompok kontrol; evaluasi dampak dilaporkan terpisah.

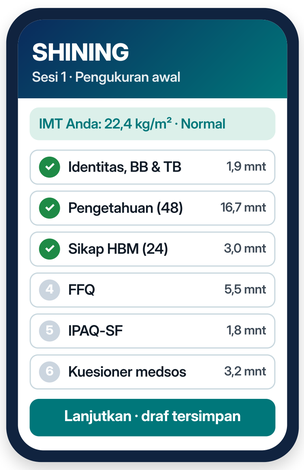
4 Alur Penelitian (Model ADDIE)

1. **Analysis** (Analisis kebutuhan) — Kajian literatur, survei awal, analisis kebutuhan
2. **Design** (Desain media) — Desain konten berbasis *Health Belief Model* (HBM)
3. **Development** (Pengembangan) — Pengembangan platform SHINING dan materi edukasi

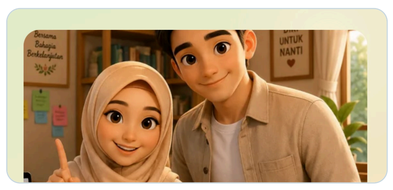
FOKUS MAKALAH INI

4. **Implementation** (Implementasi) — Uji coba, rekrutmen peserta, implementasi edukasi online
5. **Evaluation** (Evaluasi) — Analisis proses, pola penggunaan media, dan evaluasi dampak

5.1 Hasil · Platform SHINING — Tujuan 1



Gambar 2. Alur sesi 1 (median waktu pengisian)



- **Web satu halaman, ramah HP:** tanpa unduh aplikasi dan tanpa membuat akun.
- **Masuk dengan nama + nomor HP/WA**, lalu cek kelayakan (catin 20–40 tahun) dan persetujuan.
- **Enam instrumen sesi 1:** identitas (BB & TB), pengetahuan, sikap HBM, FFQ, IPAQ-SF, kuesioner medsos.
- **Umpan balik IMT & status gizi** langsung tampil sebagai informasi sekaligus *engagement*.
- **Tersimpan otomatis ke Google Sheets**; nomor HP/WA sebagai penanda peserta.
- **Kiriman berulang ditandai**; data tak dikenali masuk **lembar karantina** untuk verifikasi manual.
- **Penilaian awal (15 mahasiswa):** kelima aspek mudah (rerata 4,40–4,73 dari 5; total 22,8 ± 2,3 dari 25); terendah pada pengisian kuesioner.

5.2 Hasil · Pengembangan Iteratif — Tujuan 1



Siklus pengembangan iteratif

Akhir Juli	**MASALAH** Persetujuan tidak tersimpan; angka nol nomor HP hilang; status "selesai" hanya di HP	**PERBAIKAN** Skrip ditulis ulang (normalisasi nomor, karantina, penanda duplikat); status dikonfirmasi server
Agustus	**PENILAIAN AWAL** Kemudahan dan keterbacaan dinilai oleh 15 mahasiswa	**CATATAN** Tidak ada masalah besar yang dilaporkan
Awal Oktober	**MASALAH** Progres hilang saat berganti telepon; isian kosong	**PERBAIKAN** Progres per nomor telepon; validasi isian; kirim ulang otomatis
Pertengahan Oktober	**MASALAH** Blok makanan pokok FFQ hilang; halaman awal terlalu banyak tahap	**PERBAIKAN** Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis
Akhir Oktober	**STATUS** Pendaftaran kelompok kontrol ditutup	**TINDAK LANJUT** Data dikunci untuk analisis

13,8% kiriman berulang (186 dari 1.344 rekaman)

22/23 rekaman karantina di minggu pertama

26,9%→0% FFQ tanpa makanan pokok setelah simpan draf (p=0,04)

5.3 Penyelesaian Instrumen Sesi 1 — Tujuan 1 — n = 198

TAHAP	DIKIRIM, N (%)	VALID	MEDIAN (RAK), MNT
Persetujuan	171 (86,4%)	–	–
Formulir identitas	161 (81,3%)	160	1,9 (1,1–2,9)
Tes pengetahuan (48 butir)	107 (54,0%)	106	16,7 (10,7–34,4)
Skala sikap (24 butir)	96 (48,5%)	94	3,0 (1,6–4,7)
FFQ	92 (46,5%)	88	5,5 (4,0–7,8)
Kuesioner medsos	82 (41,4%)	80	3,2 (2,1–4,1)
IPAQ-SF	82 (41,4%)	67	1,8 (1,2–2,7)
Keenam instrumen	77 (38,9%)	59	–

Penurunan terbesar (81,3% → 54,0%) **sebelum tes pengetahuan**, instrumen terpanjang (Galesic & Bosnjak 2009). Setelah perbaikan, penyelesaian naik **37,2% → 55,6%** (p=0,137).

Kiriman ganda: dipakai yang paling lengkap. Valid: BB/TB wajar & butir terisi sesuai batas minimal. RAK: rentang antarkuartil.

5.4 Penggunaan Media Sosial — Tujuan 2 — n = 74

INDIKATOR	%
Platform utama: WhatsApp	59,5
Platform utama: TikTok/Instagram	33,8
Akses hampir terus-menerus (±setiap jam)	73,0
Durasi ≥3 jam/hari	51,4
Pernah mencari info prakonsepsi[a]	87,7
Selalu memeriksa kebenaran info[a]	61,6
Sumber: akun nakes/lembaga resmi[b]	75,7
Sumber: influencer[b]	39,2
Pernah tertarik produk yang dipromosikan	71,6

WhatsApp efektif sebagai pengingat kesehatan (Laurence et al. 2025)**; ketertarikan pada produk promosi perlu diwaspadai** (Agustiani et al. 2026)**.**

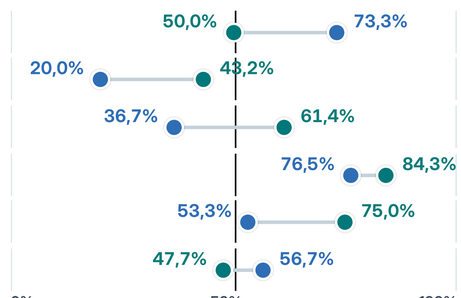
Subjek: 59,5% perempuan; 60,6% ≤SMA. [a]n=73. [b]Boleh lebih dari satu sumber.

5.5 Hubungan Medsos, Pengetahuan, Sikap & IMT — Tujuan 2

Variabel	Pengetahuan	Sikap HBM	IMT
Frekuensi akses	−0,092 (0,436)	0,031 (0,796)	0,038 (0,746)
Durasi harian	0,175 (0,135)	0,199 (0,090)	**−0,331 (0,004)***
Mencari info prakonsepsi	0,057 (0,631)	0,216 (0,066)	−0,181 (0,125)
Memeriksa kebenaran info	0,116 (0,327)	**0,287 (0,014)***	0,042 (0,723)
Platform utama[a]	– (0,088)	**– (0,006)***	– (0,919)
Sumber nakes/resmi[b]	– (0,950)	– (0,456)	**– (0,022)***
Skor pengetahuan	–	**0,414 (<0,001)***	−0,009 (0,939)
Skor sikap	–	–	−0,212 (0,070)

r_s Spearman (p). [a]Kruskal-Wallis; sikap terendah pada pengguna WhatsApp. [b]Mann-Whitney; median IMT 22,5 vs 26,6 kg/m². *p<0,05.

5.6 Menurut Peran Catin — Tujuan 2



Catin laki-laki lebih tua dan seluruhnya bekerja; pengetahuan & sikap cenderung lebih rendah (sejalan Zahra et al. 2024), tetapi tidak lebih mudah berhenti (selesai 47,0% vs 47,9%; p=0,910).

*p<0,05 (khi-kuadrat/eksak Fisher; Mann-Whitney untuk skor).

6 Simpulan, Saran & Implikasi

SIMPULAN

- Platform web sederhana dapat dipakai, namun **beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data tak terlihat** perlu diantisipasi sejak perancangan.
- Penggunaan medsos catin **intensif dan didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap HBM, tetapi **>50% catin berat badan lebih/obesitas**.
- IMT lebih rendah & sikap lebih positif berhubungan dengan **sumber kredibel dan memeriksa kebenaran informasi**, bukan frekuensi akses.

SARAN

- Gunakan **instrumen ringkas** dan pantau data secara rutin.
- Biasakan catin **memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk**, dan gunakan referensi kredibel.
- Manfaatkan **WhatsApp** untuk pengingat dan pendampingan.

IMPLIKASI

- **Tes panjang dipecah** ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut.
- **Pengingat terjadwal** via WhatsApp menekan angka berhenti.
- **Kiriman ganda & HP bersama** ditangani dengan penanda peserta dan aturan baku.
- **Penyimpanan dikonfirmasi server**; data dipantau tiap minggu.
- **Pesan sesuai peran:** laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via TikTok/Instagram.
- **Perubahan didokumentasikan** bertanggal; kelompok kontrol–intervensi dipisah.

Keterbatasan: sampel kecil, BB/TB isian sendiri, eksploratif tanpa regresi, potong lintang; alasan berhenti tidak terekam.

7 Ucapan Terima Kasih

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- Calon Pengantin Kota Binjai
- Seluruh pihak yang berkontribusi

Akses SHINING
mulai.edukasi-catin.id

1. Pindai QR atau buka tautan
2. Isi nama dan nomor WhatsApp
3. Baca persetujuan, lalu mulai

Pustaka utama. Amiri P et al. 2023. BMC Health Serv Res 23:1176 · Atmaka DR et al. 2022. Media Gizi Indones 17(1SP):1–5 · BPS 2025 · Chen X et al. 2018. J Health Commun 23(8):724–734 · Denniss E et al. 2024. IJBNPA 21:16 · Eysenbach G. 2005. JMIR 7(1):e11 · Eysenbach G. 2011. JMIR 13(4):e126 · Faverio M, Sidoti O. 2024. Pew Research Center · Galesic M, Bosnjak M. 2009. Public Opin Q 73(2):349–360 · Janz NK, Becker MH. 1984. Health Educ Q 11(1):1–47 · Lam BT et al. 2025. JMIR 27:e67640 · Laurence MC et al. 2025. Front Digit Health 7:1542006 · Lim MSC et al. 2022. JMIR 24(1):e23656 · Meyerowitz-Katz G et al. 2020. JMIR 22(9):e20283 · Musgrave L et al. 2023. JMIR 25:e41900 · Stephenson J et al. 2018. Lancet 391:1830–1841 · Zahra SS et al. 2024. HPCEJ 3(1)